

Substance	Mécanisme d'action toxique	Toxidrome lésionnel ou fonctionnel	Antidote	Remarques importantes
Paracétamol	Formation d'un métabolite réactif (NAPQI)	Hépatite fulminante Toxique lésionnel	N-acétylcystéine (NAC)	<u>Facteurs de risques</u> : Alcool, dénutrition, induction enzymatique Intérêt paracétamolémie + nomogramme de Prescott ou Rumack-Matthew
Salicylés	Stimulation SNC Alcalose respiratoire Acidose métabolique ↗ Trou anionique	Hyperpnée, hyperthermie, acouphènes...coma, détresse respiratoire Toxique fonctionnel	/	Intérêt salicylémie + nomogramme (Done) Alcalinisation des urines ± hémodialyse Intoxication grave aux âges extrêmes
Opioïdes	↗ Effets pharmacologiques : agonistes récepteurs opioïdes	<u>Toxidrome opioïde</u> : coma, bradypnée, myosis (triade caractéristique) Toxique fonctionnel	Naloxone	Méthadone : allongement QT Tramadol : convulsions /!\ Syndrome de sevrage
Anti-dépresseurs tricycliques	Antagonistes muscariniques Effet stabilisant de membrane	Troubles cardiovasculaires (effet stab mb) <u>Toxidrome anticholinergique</u> : bouche sèche, mydriase, constipation Toxique fonctionnel	/	Gravité : allongement QRS, convulsions
Benzodiazépines	↗ Effets pharmacologiques : agonistes GABA _A	<u>Toxidrome de myorelaxation</u> : coma, hypotonie, hyporéflexie Toxique fonctionnel	Flumazénil	Propriétés des benzodiazépines : HAMAC Bon pronostic en cas d'intox /!\ Syndrome de sevrage
Chloroquine	Effet stabilisant de membrane + vasodilatateur + inotrope négatif	PAS de signes annonciateurs Choc cardiogénique Arrêt cardiaque très rapide = ACR en 4-8h Toxique fonctionnel	/	Urgence extrême !! Pronostic réservé (=peu favorable) Intérêt chloroquinémie <u>Gravité</u> : dose > 4g, QRS > 100 ms et PAs < 100 mmHg Adrénaline + diazépam
Digoxine	↗ Effets pharmacologiques : blocage pompe Na ⁺ /K ⁺	<u>Prodromes</u> : digestifs + neurosensoriels <u>Phase d'état</u> : trouble du rythme Toxique fonctionnel	Fab anti-digoxine	Intoxication grave : mortalité 20 % Intérêt digoxinémie pour neutralisation (semi-molaire ou équimolaire) 40 mg de Fab antidigitaliques (1 flacon) neutralisent 0,5 mg de digitalique
Antipsychotiques	↗ Effets pharmacologiques : antagonistes D2, muscariniques	Syndrome extra-pyramidal Toxidrome anticholinergique Syndrome malin des neuroleptiques Toxique fonctionnel	/	<u>Gravité</u> : convulsions, arythmie, choc, coma... Syndrome malin (fièvre, rigidité): mortalité 10% Myorelaxant spécifique : dantrolène ± bromocriptine

Substance	Mécanisme d'action toxique	Toxidrome lésionnel ou fonctionnel	Antidote	Remarques importantes
IRS, IRSNa, IMAO, autres	➤ Effets pharmacologiques : 5HT, NA	Toxidrome sérotoninergique Toxidrome adrénergique Toxique fonctionnel	/	Bon pronostic : SAUF syndrome sérotoninergique (agitation, tremblements, hyperthermie, mydriase) : mortalité 10 %
Lithium	Troubles électrolytiques (organes cibles = flux d'ions importants)	Symptômes neurologiques, cardiovasculaires, rénaux, digestifs Toxique fonctionnel	/	<u>Gravité</u> : prise aiguë chez un sujet traité, surdosage chronique Intérêt lithémie : hémodialyse si [Li] > 4mM ± IRA ± atteinte neurologique Délai entre pic lithémie et pic toxicité (BHE)
Éthanol	Stress oxydant Formation d'adduits Dépression SNC (ago GABA, antago NMDA) Acidose métabolique ➤ Trou osmolaire ➤ Trou anionique CIRC 1	<u>Intox aiguë</u> : toxidrome de myorelaxation Toxique FONCTIONNEL <u>Intox chronique</u> : SNC, coeur, foie, pancréas, cancer, dépendance...	/	Enzymes clés : ADH et ALDH Cinétique d'ordre 0 Syndrome de sevrage (jusqu'au delirium tremens) PAS de SEUIL /!\ SAF Hémodialyse exceptionnelle (> 6g/L)
Méthanol	Dépression SNC Acidose métabolique ➤ Trou osmolaire ➤ Trou anionique	Toxique fonctionnel ± lésionnel	Éthanol Fomépizole Folates	Enzymes clés : ADH et ALDH Cinétique d'ordre 0 2 phases : 0-2h puis 12-24h Troubles oculaires caractéristiques Hémodialyse possible
Éthylène-glycol	Dépression SNC Acidose métabolique ➤ Trou osmolaire ➤ Trou anionique	Toxique fonctionnel	Éthanol Fomépizole	Enzymes clés : ADH et ALDH Cinétique d'ordre 0 3 phases : 4-12h puis 12-24h puis 24-72h Cristaux d'oxalate de Ca caractéristique Hémodialyse possible
Benzène	Irritation Stress oxydant Dépression SNC CIRC 1	Toxicité chronique Toxidrome hydrocarbures aromatiques Toxidrome solvants	/	Retrouver dans cigarettes et/ou EXPOSITION PROFESSIONNELLE Hémopathies, LAM VTR
Monoxyde de carbone	Carboxyhémoglobine	Toxique fonctionnel	O ₂ normobare ou hyperbare	Syndrome post-intervalle = troubles neuropsychiatriques APRÈS une apparente récupération complète

Substance	Mécanisme d'action toxique	Toxidrome lésionnel ou fonctionnel	Antidote	Remarques importantes
Plomb	Déplace métaux Compétition Ca^{2+} CIRC 1 ou 2A ou 3	Toxicité chronique = saturnisme SNC, rein, hémato	Chélateurs BAL EDTA Ca^{2+} Succimer	Enfant (« pica ») ou exposition professionnelle PAS DE SEUIL VTR dont VLB professionnelle (seule VLEP contraignante)
Dioxines	Modulation de l'activité transcriptionnelle CIRC 1	Toxicité chronique Reprotoxicité Tératogène Troubles neurocomportementaux	/	Stockage dans les graisses /!\ Lait maternel EFFET SEUIL VTR
Organophosphorés	Anticholinestérasiques	Toxidrome cholinergique	Atropine Pralidoxime	Gaz de combat ou insecticides EXPOSITION PROFESSIONNELLE 2 étapes : inhibition réversible puis irréversible (« aging ») = vieillissement enzyme